

## 29 - 05- GROSSES BOURSES - Pr. Lakmichi

Les grosses bourses, c'est une augmentation du volume des bourses, qui peuvent être aiguës ou chroniques, peuvent être dues à plusieurs infections et l'imposent à un examen clinique rigoureux pour établir un diagnostic topographique ou bien étiologique. Les explorations cliniques commencent d'abord par un anamnèse pour authentifier des antécédents médicaux du patient, est-ce que c'est un patient diabétique, un patient hypertendu, un patient qui avait des antécédents de tuberculose, un patient qui a reçu un traumatisme au niveau de l'effet gour, l'âge du patient. Le mode de début est très important pour faire la part entre l'aiguë et le chronique.

L'aiguë, ça se développe en quelques heures, le chronique plusieurs semaines, voire des mois. Est-ce que ces grosses bourses sont associées à un certain nombre de signes généraux, à savoir la fièvre, l'altération de l'état général ou autres, ou bien des signes fonctionnels à savoir des troubles médicaux, etc. Toujours dans la clinique, on doit inspecter les bourses pour évaluer leur volume, l'aspect de la pose crotale est très important, est-ce que c'est une pose crotale qui est le plus souvent tendue, est-ce qu'elle est luisante, la position du testicule, le testicule qui est en place ou bien celui qui est surélevé, très important, vous allons voir pourquoi.

Est-ce qu'il n'y a pas de ficule au niveau de la pose crotale qui donne issue à du pus, et par la suite, procéder à la palpation qui doit être douce et prudente. On cherche le testicule, on essaie de le palper de la manière dont on a vu au cours de l'examen physique, c'est-à-dire c'est un palpé pie manuel, on fixe le testicule avec une main, on examine les pyjames avec l'autre et vice-versa, on cherche le sillon inter-pyjamaux testiculaire et ne pas oublier d'examiner la bourse contrôlataire. L'examen doit comprendre à tout caractère et on doit évaluer l'aspect du sillon.

Quant aux diagnostics étiologies, c'est-à-dire les causes qui conduisent à ces grosses bourses, lorsqu'il s'agit d'une grosse bourse aiguë, la torsion du gourdon spermatique vient en premier lieu comme cause de grosse bourse aiguë, suivie par pathologie infectieuse et inflammatoire qui est l'épidémie et les grosses bourses post-traumatiques. Quant aux causes chroniques, le cancer de tissu cul vient en premier lieu, l'hydrocène en deuxième lieu, le varicocène et l'équice de l'épidémie. Nous allons détailler ces pathologies.

Premièrement, les grosses bourses aiguës lorsqu'il s'agit d'une orchie pyjimate, c'est une infection du testicule et de l'épidémie, infection bactérienne ou virale, on parle d'orchie pyjimate ou virale le plus souvent chez les enfants. Ces infections peuvent être contractées par voies ascendantes le plus souvent, ascendantes à travers infections urinaires, les germes au niveau des lourètres, qui vont infester, qui vont remonter le long des voies séminales, le canal déferrant, l'épidémie et puis le testicule, c'est une voie, on dit voie ascendante, c'est la voie la plus fréquente, exceptionnellement, il y a la voie sanguine ou la voie infatigée. Cliniquement, il s'agit d'une infection, du testicule et de l'épidémie, l'infection va donner une inflammation et par conséquent une fièvre, une douleur scrotale intense, lancinant, avec une augmentation du volume scrotale.

Cette augmentation de volume s'associe à une peau qui est lisse, nuisante et parfois tendue et chaude. Après la clinique, le bilan biologique, qui n'est pas nécessaire ni fondamental pour établir le diagnostic, le diagnostic est avant tout clinique, mais sur le plan biologique, on peut trouver une hyperleucocytose à l'allumération de formules sanguines et à l'échographie, un testicule qui est augmenté de volume, qui est hétérogène. Le CPU, s'il est réalisé, doit rechercher une infection urinaire associée.

Le deuxième diagnostic responsable d'une grosse bourse aiguë, c'est la torsion testiculaire ou plutôt la torsion du cordon spermatique. Si c'est une urgence chirurgicale par excellence, il ne doit souffrir d'aucun retard, elle survient le plus souvent et le plus fréquemment chez l'adolescent en 13 et 18 ans. Du fait de la torsion du cordon spermatique et des spires de torsion, la vascularisation artérielle testiculaire est nettement compromise et donc il y a un risque ischémique important pour les testicules et s'il n'est pas traité, il va évoluer vers la nécrose testiculaire.

Cliniquement, c'est un début qui est brutal. L'adolescent peut vous dire à quelle heure exacte. La température normale, il n'y a pas de fièvre, c'est une grosse bourse, douloureuse, irradiant le long du cordon avec un testicule qui est rétracté, c'est-à-dire un testicule qui remonte.

Du fait des spires de torsion, le cordon spermatique réduit de longueur et par conséquent, le testicule remonte. L'évolution, comme on a dit, se fait vers la nécrose testiculaire. Le diagnostic différentiel, il n'y en a pas plusieurs, c'est la torsion de l'idacite manganique qui est un reliquat embryonnaire au pôle supérieur du testicule qui peut se tendre et donner les mêmes aspects.

Là, c'est un schéma qui montre la torsion du cordon spermatique du côté gauche, la flèche qui montre le sens de la torsion. Nécrose bourse post-traumatique. Généralement, des traumatismes fermés du scrotum sont l'accident de sport, les coups de pieds au cours du RICS, les chutes d'un caillifaucchon.

Cliniquement, c'est un tableau qui est parlant. C'est un patient qui a eu une douleur syncopale scrotale lors du traumatisme avec une augmentation du volume scrotal dans les heures qui suivent le traumatisme. L'examen clinique et l'échographie scrotale sont d'un grand apport, surtout pour l'échographie scrotale pour le bilan lésionnaire.

Les autres étiologies des grosses bourses, les grosses bourses chroniques, comme on a dit, c'est une affection ou ce sont des affections qui évoluent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou années. Le premier diagnostic à évoquer devant une grosse bourse chronique, c'est le cancer des testicules. Il parvient par ordre de prévalence, surtout chez l'adulte jeune entre 25 et 35 ans.

Cliniquement, c'est un testicule qui est dur, bosselé et peu douloureux, avec une pause scrotale normale, l'épiglyme sain, un signe de chevassu positif et une palpation des seins qui montre une

gynécomastie. La paraclinique, c'est des marqueurs tumoraux, on dose surtout les marqueurs tumoraux, l'alpha-fetoprotéine, l'ASCG. Les examens radiologiques, c'est l'échographie scrotale qui montre une masse tissulaire, testiculaire.

Le scanner abdominal n'est pas nécessaire pour le diagnostic, mais plutôt pour le diagnostic d'extension à la recherche de métastases ganglionnaires, lambo-artiques. Je vous rappelle que le drainage lymphatique des testicules se fait en rétro-péritoneal autour des gros vaisseaux. C'est jusqu'au médiastin.

C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs un scanner thoracique à la recherche de métastases médiastines. L'autre diagnostic de Grossebourg, c'est l'hydrocèle. L'hydrocèle, c'est un épanchement liquidien dans la vaginale tessulaire, peut être essentiel, c'est-à-dire de causes inconnues, la plus fréquente chez l'adulte, comme il peut être secondaire à des infections tessulaires, un petit épigénite, un traumatisme, ou il y a un cancer tessulaire.

On dit bien que la vaginale est le miroir de ce qui se passe dans le tessucule. À chaque fois qu'il y a une infection tessulaire, il y a la vaginale qui se trouve irritée et qui risque de répondre par un épanchement liquidien entre ces deux feuillets. A l'opposé, il peut être congénital par persistance du canal péritonique vaginal chez l'enfant.

Et donc, c'est une bourse qui va continuer à drainer le liquide péritonéal. Cliniquement, c'est une grosse bourse indolore avec une augmentation du volume qui est longue, une pause crotale qui est normale avec une perte de glissement. À la palpation, c'est une formation lisse, grimitante.

Les tessucules épigénites sont souvent non palpables, c'est parce qu'on n'arrive pas à les palper parce qu'ils sont entourés par du liquide au sein des enveloppes strotos qui sont tendues par ce liquide. Et par conséquent, on n'arrive pas à réaliser le pincement vaginal. L'échographie crotale, là c'est une image d'un tessucule avec l'épigénite entourée de liquide qui paraît en noir.

Les grosses bourses chroniques, les restes diagnostiques, il y a une piste du cordon spermatique, c'est une petite poche liquidienne perçue au niveau du cordon, elle est due à une résorption incomplète du canal péritoneau vaginal, c'est une pathologie pédiatrique. Piste de l'épigidime, c'est une petite poche liquidienne perçue le plus souvent au niveau de la tête de l'épigidime, on parle cliniquement d'un nodule épigidimaire, mais il s'agit en fait d'une petite poche liquidienne, une petite piste liquidienne au niveau de l'épigidime, un contenu séreux ou séminal. Dernier diagnostic des grosses bourses chroniques, ce sont les varicocelles.

Par définition, c'est une dilatation variqueuse des veines spermatiques, secondaire à une insuffisance valvulaire, ce sont les valvules au niveau de ces veines qui sont insuffisantes et qui permettent un reflux du sang de la veine rénale à gauche ou de la veine cave à droite, mais le plus souvent à gauche, et par conséquent, il y a un réseau veineux au niveau du cordon spermatique et du tessucule qui va regorger du sang et va donner le tableau typique de la varicocelle. Ça peut être essentiel ou secondaire, secondaire à un cancer durant qui va envahir

la veine rénale et donc le plus souvent chez un patient qui paraît dans les quelques semaines avoir une varicocèle secondaire à cette tumeur qui envahit la veine rénale, mais c'est une pause qui est exceptionnelle, la pause la plus fréquente, c'est une pause essentielle par insuffisance valvulaire. Cliniquement, on examine le sujet debout puis couché, le patient y ressent une certaine pesanteur scrotal, ce n'est pas une véritable douleur, mais c'est une pesanteur scrotal, exceptionnellement une douleur scrotal gauche à l'effort pour la fin de journée.

À l'examen, l'inspection remarque un hémiscrotone qui est parcouru de varicosité, on arrive à voir les saillies des veines spermatiques dilatées au-dessous de la pause scrotal et du cordon spermatique avec une augmentation du volume à la toux et en position debout. Lors de l'hyperpression abdominale, on exagère, on accentue le reflux du sang vers le plexus veineux au niveau du cordon et des cicules et par conséquent, on verra des veines qui sont urgescentes sans les tunifaxons qui sont flasques, molasques occupant le scrotal et le cordon spermatique. Malheureusement, c'est une pathologie qui conduit vers l'infertilité masculine.

L'échographie scrotale du varicocèle va donc déceler des veines qui sont dilatées et l'échographie couplée au Doppler va évaluer exactement le degré du reflux sanguin au niveau des veines spermatiques. Toujours dans le chapitre Grosse Bourse chronique, on trouve l'éléphantiasis scrotal. C'est une pathologie qui est très rare, c'est une augmentation du volume scrotal plutôt par épaississement inflammatoire de la pause scrotal.

La cause, c'est une infection par une mycose, un parasite qui s'appelle la chilariose qui va donc boucher les canaux lymphatiques, le drainage lymphatique scrotal et donc la lymphe va rester emprisonnée au niveau de la pause scrotal et qui va donner cette augmentation longue au niveau du scrotal avec un poids scrotal qui peut atteindre parfois plusieurs kilos. Et vous imaginez bien que c'est une peau qui est sclérose et épaissie. C'est une pathologie qui reste exceptionnelle et rarifiée.

L'autre cause des Grosses Bourses chroniques, ce sont les orchidées tuberculeuses fistulisées. Je vous rappelle qu'on est un pays d'endémies tuberculeuses et donc on est en droit d'évoquer le diagnostic d'orchidite tumique tuberculeuse devant une Grosse Bourse chronique qui peut être souvent révélatrice d'une tuberculose urogenitale. Dans la clinique, on peut avoir un ondule épidympère fistulisé ou non à la pause scrotal avec le plus souvent un canaux déférent irrégulier en chapelet qui traduit des sténoses qui sont étagées au niveau de l'épididyme.

Par conséquent, toute épidympite fistulisée est une épidympite tuberculeuse jusqu'à preuve du contraire. Le dernier chapitre des lésions des Grosses Bourses chroniques, ce sont les abcès purulents, lésions purulentes et gangréneuses du scrotum, à savoir en premier lieu les abcès urinaires qui sont une supérotation de la pause scrotal à partir des urines ayant infiltré le scrotum et le périnée. C'est souvent une complication des rétrécissements de l'urètre.

Un rétrécissement de l'urètre ou une sténose, en amont, il se produit des trajets fistuleux qui vont

parcourir les espaces anatomiques scrotaux pour induire une infection et par conséquent des lésions purulentes et gangréneuses du scrotum. Cliniquement, elle se traduit par une fièvre, une dysurie ou une rétention aiguë d'urine qui est leur origine, un gros scrotum inflammé et douloureux avec la présence d'une lésion fistule purulente. Les lésions purulentes et gangréneuses toujours du scrotum, il y a la gangrène scrotal, la gangrène scrotal qui est une nécrose infectieuse aiguë du scrotum, qui est souvent due à des germes anaérobiques et qui est de très mauvais pronostic, on peut l'assimiler à un sepsis, dont la prise en charge est difficile.

Cliniquement, c'est un début qui est brutal avec une température très élevée à 40°C en plateau, un teint infecté grisâtre et une douleur lancinante du scrotum. C'est une pathologie qui survient chez des terrains particuliers, des patients diabétiques, des patients qui sont immunodéprimés et l'installation de la gangrène est très rapide. L'état général est souvent atterré avec un pouls rapide, une hypotension conduisant à un état de choc infectieux et un gros scrotum bien entendu avec des marbrures, des plaques noires, des escares.

Le traitement doit être une antibiothérapie à large spectre, une résection large des nécroses, un drainage des puits et un débridement large. Le pronostic est généralement fâcheux.